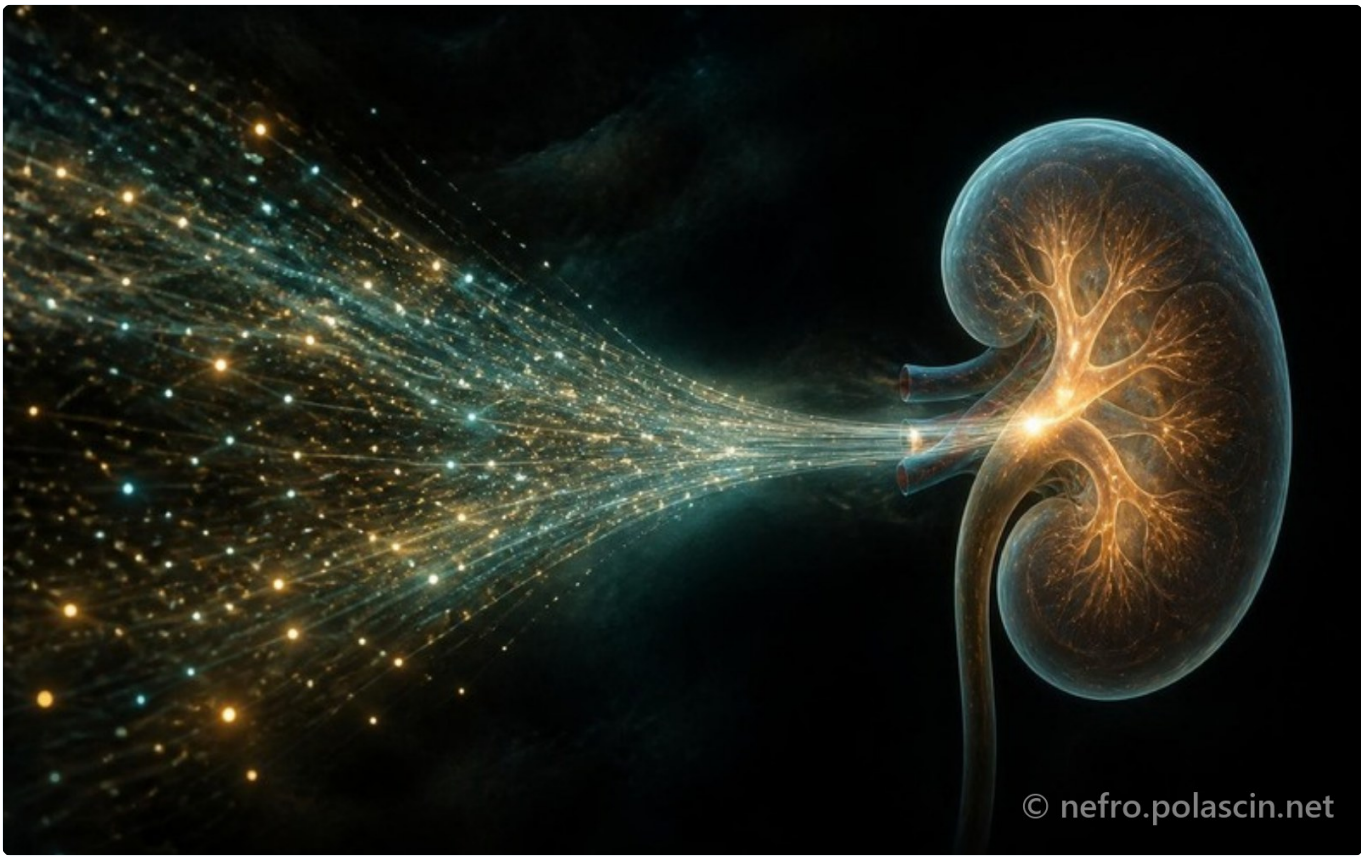
Post-kongresová analýza ERA 2026 pre nefrológiu: ako preniesť „highlights“ do praxe pri CKD, dialýze, transplantácii a kardiovaskulárnom riziku

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 01.07.2026



Ilustračná scéna. Z množstva kongresových výstupov sa do praxe dostane len to, čo vydrží zúženie na konkrétne rozhodnutie.

Po veľkých odborných kongresoch, ako je ERA, máme často pocit, že „bolo toho veľa“, no v ambulancii potrebujeme rýchlo určiť, čo z toho má praktický dosah. Tento post-kongresový materiál prináša hlavné výstupy so zameraním na **manažment kardiovaskulárneho rizika, transplantáciu, dialýzu a chronické ochorenie obličiek (CKD)**. Je to dobrý rámec pre vlastný protokol nefrologickej praxe.

Nižšie rozoberám, ako by mal vyzerať prenos týchto tém do každodenného rozhodovania. Materiál je zámerne rámcový: konkrétne štúdie, dávky a presné odporúčania si treba overiť priamo v zázname z kongresu; tu sa sústredím na to, ako ich preniesť do praxe.

1) Kardiovaskulárne riziko pri CKD: z „renálneho rizika“ sa stáva CKM prístup

Pri CKD je kardiovaskulárne riziko často dominantné a rozhodnutia nie sú len o eGFR. Po kongrese je užitočné ujasniť si v praxi tri veci:

1. **Ktorý pacient je „KV dominantný“?** Nielen podľa diagnózy, ale aj podľa klinických znakov (anamnéza KV príhod, krvný tlak, albuminúria, priebeh ochorenia, metabolické faktory).
2. **Čo je cieľ a ako ho budem sledovať?** Aj keď sa ciele medzi pracoviskami líšia, dôležité je, aby sa nefrológ nestratil v reťazci meraní a liekov a mal vlastnú logiku sledovania.
3. **Kde je rozhodovanie najčastejšie „rozbité“ medzi odbormi?** Typicky ide o koordináciu medzi nefrológiou, diabetológiou a kardiológiou, aby pacient nemal paralelné, ale nekonzistentné plány.

Prakticky: v ambulancii je dobré zaviesť pri každej kontrole krátke zhodnotenie CKD a KV rizika, ktoré sa neopiera len o laboratóriá, ale aj o komorbiditu a rizikový profil.

2) Transplantácia: od jednotlivých príhod k systému sledovania a prevencie

V oblasti transplantácie býva najväčší prínos kongresových výstupov v dvoch typoch tém:

- **monitorovanie** (čo a ako často, čo je „varovný signál“),
- **prevencia** (infekcie, metabolické komplikácie, dlhodobé riziko funkcie štepu).

Post-kongresový prístup by preto mal viesť k jednoduchým zmenám protokolu, napríklad:

- spresnenie, čo presne sa hodnotí pri zhoršení (neuspokojiť sa len s „trendom“ kreatinínu),
- jasné „rozhodovacie body“, kedy eskalovať (pacient, laboratóriá, zobrazovanie, biopsia alebo iná diagnostika podľa lokálneho algoritmu).

3) Dialýza: kvalita liečby nie je len dávka, ale aj výsledok a bezpečnosť

Pri dialýze často chceme „čo najviac“ parametrov, no klinicky rozhodujú:

- **stabilita pacienta** (interdialytické ťažkosti, hypotenzné epizódy, tolerancia),
- **bezpečnosť a riziká** (infekcie, vaskulárny prístup, elektrolytové výkyvy),
- **dlhodobé ciele** (hospitalizácie, nutričný stav, anémia, minerálovo-kostný metabolizmus).

Ak sa výstupy z ERA v týchto oblastiach potvrdzujú, odporúčam prepracovať protokol na dialyzačnom lôžku tak, aby:

- bolo jasné, ktoré parametre vyžadujú zásah,
- bolo jasné, čo je prvá línia úpravy (a čo nie),
- a aby dialyzačný tím a nefrologický tím komunikovali v tej istej logike.

4) CKD: ako zabrániť tomu, aby sa sledovanie zmenilo na samoúčelné meranie

Pri CKD je najčastejšia chyba „meriam všetko, ale neviem, čo to mení“. Po kongrese je dobré položiť si otázky:

- Ktoré výsledky sú pre mňa signálom na zmenu terapie?
- Kedy opakujem vyšetrenie a s akým cieľom?
- Čo robím, keď sa cieľ nedarí (a nielen „čakám na ďalšiu kontrolu“)?

Práve tu má nefrológ najväčší vplyv: v pretavení dát do rozhodovania.

Zdroj: *„Post-Kongress: ERA 2026“, STREAMED UP / NephroLive (2026). Link na zdroj (video).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=era-2026-post-kongres-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.